

位患者骶部创口皮肤发生坏死后继发金黄色葡萄球菌感染,使用敏感抗生素治疗后感染得到控制。1 例外固定针孔感染后皮肤出现红肿,有脓性液体渗出,使用抗生素和换药后好转。1 例患者因出现术侧下肢麻木证实为股外侧皮神经损伤,1 个月后逐渐好转。3 例患者术后出现下肢深静脉血栓,使用尿激酶溶栓和低分子肝素皮下注射后好转。骨折愈合时间 2~4 个月,平均 3.4 个月。采用门诊随访和电话随访的方式对本组 42 例患者随访 3~5 a,3 例患者失访。39 例随访患者术后状态良好,除部分患者主诉有骶尾部和下肢疼痛外,其余患者恢复良好,活动正常。

3 讨论

车祸或高处坠落引起的高能量骨盆骨折的发生率越来越高,应得到重视。对于骨盆骨折并伴有腹部损伤和失血性休克患者,首先要处理失血性休克病因并抗休克治疗,对于骨盆骨折可以二期处理^[5]。同时,骨盆骨折患者还常伴有其他部位如椎体、股骨头、下肢骨部位的骨折,容易忽略。

传统的切开复位内固定手术术后效果一般,并发症多。而最近兴起的有限切开内固定结合外固定治疗则解决了这一难题,有效地提高了手术效果。外固定架治疗骨盆骨折一般用于大量出血而不能有效控制的患者和某些前环不稳定、后环部分韧带损伤的患者,但

对于垂直不稳定型 Tile C 型骨盆骨折损伤的治疗效果尚不确定^[6]。本研究中 42 例患者采用有限切开内固定并结合外固定的方法治疗骨盆骨折患者取得了良好的治疗效果。经 3~5 a 的随访,绝大部分患者术后恢复良好,无严重并发症,无活动障碍,疗效满意。该研究结果表明,有限切开内固定结合外固定器治疗骨盆骨折效果好,安全性高,值得推广。

参考文献

- [1] Kabak S, Halici M, Tuncel M, et al. Functional outcome of open reduction and internal fixation for completely unstable pelvic ring fractures (type C): a report of 40 cases [J]. J Orthop Trauma, 2003, 17(8): 555-562.
- [2] 刘利民, 雍宜民, 沈惠良. 不稳定型骨盆骨折外固定技术的应用 [J]. 中华创伤杂志, 2000, 16(1): 10-13.
- [3] 辛景义, 马宝通, 曹红彬, 等. 有限切开内固定结合外固定器治疗 Tile C 型骨盆骨折 [J]. 中华骨科杂志, 2008, 28(7): 563-566.
- [4] 宗兆文, 沈岳. 骨盆骨折并发症的诊疗进展 [J]. 重庆医学, 2010, 39(9): 1088-1091.
- [5] 游小军. 经皮微创空芯加压螺钉内固定术治疗 Tile C1 型骨盆骨折临床观察 [J]. 山东医药, 2011, 51(19): 50-51.
- [6] 贾健, 金鸿宾. 骨盆损伤的诊断及外科治疗 [J]. 中华骨科杂志, 2000, 20(2): 121-123.

(收稿日期: 2013-10-09)

低频电刺激与盆腔生物反馈治疗女性压力性尿失禁

白素霞, 王新芳, 李 红, 秦 蕾, 张华丽

(漯河市第三人民医院 妇产科 河南 漯河 462000)

摘要: 目的: 探讨低频电刺激与盆腔生物反馈治疗女性压力性尿失禁的临床疗效。方法: 随机选取漯河市第三人民医院 2010 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日门诊收治的 68 例女性压力性尿失禁患者为研究对象, 采取低频电刺激与盆腔生物反馈方法治疗, 对治疗后的效果进行分析。结果: 治疗后盆底肌力恢复情况效果显著, 漏尿指数也明显下降, 尿失禁治疗的有效率达到 89.7%, 治疗前后对比差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 电刺激与盆腔生物反馈治疗可显著改善女性患者压力性尿失禁的症状, 改善盆底肌力, 提高患者生活质量。

关键词: 低频电刺激; 盆腔生物反馈; 女性; 压力性尿失禁; 疗效

中图分类号: R 694.54 **doi:** 10.3969/j.issn.1004-437X.2013.06.044

压力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI) 是一种被称为“社交癌”的严重困扰中老年妇女的常见病。国际控尿学会将 SUI 定义为构成社会 and 卫生问题, 且客观上能被证实的不自主的尿液流出^[1]。近年

来随着医疗技术的发展, 手术治疗取得很大的进步, 但医疗费用昂贵且并发症多, 对于许多尿失禁程度较轻的患者现多主张采用非手术治疗。本文对漯河市第三人民医院 2010 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日门

诊收治的 68 例采用低频电刺激与盆腔生物反馈治疗的女性压力性尿失禁患者的治疗效果进行分析和总结,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机选取漯河市第三人民医院 2010 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日门诊收治的女性压力性尿失禁患者 68 例为研究对象。年龄 37 ~ 68 岁,平均年龄 (45.3 ± 5.3) 岁。其中轻度尿失禁患者 27 例,中度尿失禁患者 41 例。本研究提出的纳入标准:符合轻、中度女性压力性尿失禁的诊断标准,且愿意接受此项治疗者,排除其他疾病及重度尿失禁患者。

1.2 分级标准^[4] 轻度:漏尿仅发生在咳嗽、打喷嚏和大笑时;中度:漏尿发生在日常活动中,如突然运动、快速行走及跳跃时均可发生;重度:站立时即可发生持续性漏尿。

1.3 治疗方法 采用广州杉山公司引进法国技术生产的 PHENIX USB 4 型盆底康复系列神经肌肉刺激治疗仪进行治疗。每次治疗先给予低频电刺激 20 min,再给予生物反馈 10 ~ 20 min,2 次/周,治疗 6 ~ 10 周。其它时间在家应用重量合适的盆底康复器(阴道哑铃按重量轻重不同分为 1 ~ 5 号)训练 10 ~ 20 min。详细记录治疗期间每天的排尿情况^[5]。

1.3.1 低频电刺激治疗:将阴道电极置入患者阴道内,调整输出电流,给予频率为 8 ~ 100 Hz,脉宽为 250 ~ 740 μ s 的低频电刺激治疗 20 min,电流强度控制在既能自觉盆底肌肉的跳动感,又无痛感的强度,作为唤醒患者的本体感觉,若患者处于围绝经期,需先做阴道内环境的调整。通过体内或体外的脉冲电流刺激诱发盆底肌收缩,增强盆底肌肉力量。每次治疗 20 min,2 次/周,治疗 6 ~ 10 周。

1.3.2 盆腔生物反馈:给予盆底肌肉 I 类与 II 类肌纤维及各种场景的生物反馈训练模块,让患者跟着模块训练,作为加强患者的 I、II 类肌纤维肌力及在各种场景(如:上下楼梯、抱小孩、搬东西、尿急)时,盆底肌力时刻处于收缩状态从而不会出现漏尿。医生根据反馈程序对患者的盆底肌力训练的难易度、训练时间等进行个性化的修正,记录治疗前、后盆底肌的最大收缩压力。

1.3.3 盆底康复器(阴道哑铃)训练:不做治疗期间,在家应用重量合适的阴道哑铃放入阴道内,收缩阴道肌肉并站起来,如阴道哑铃不滑出来可以模拟下蹲、上下楼、搬重物、咳嗽、跳动等方式进行训练。每天或隔

日 1 次,每次 10 ~ 20 min。

1.4 疗效评价指标 显效:尿失禁的症状消失,患者不论是在活动时、使劲用力打喷嚏、咳嗽时,或者站立时均无漏尿的现象,压力试验、抬举试验均为阴性;有效:尿失禁症状虽未完全治愈,在腹压增高的情况下仍会发生漏尿,但症状得到有效的缓解,漏尿次数减少 50% 以上;无效:漏尿次数无显著改善,甚至继续加重。总有效率为显效率和有效率之和。

1.5 统计学处理 所有数据均应用 SPSS 17.0 统计学软件统计处理,计量资料用均数 $\pm$ 标准差 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,进行 t 检验;计数资料用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

本组 68 例患者中,显效 37 例,有效 24 例,无效 7 例,总有效率为 89.7%。治疗后盆底肌力与漏尿程度较治疗前改善情况显著,差异有统计学意义 ($P < 0.05$),而且治疗过程中无并发症发生。治疗后 6 个月的随访中,仅有 2 例复发,经沟通患者同意继续采用此种方法进行治疗,1 个疗程后好转。

3 讨论

尿失禁是困扰女性的常见疾病,临床有 10% ~ 80% 的妇女有尿失禁症状,而其中 3% ~ 10% 重度患者的尿失禁症状可持续存在,严重影响患者的日常生活^[6]。临床可分为压力性尿失禁、急迫性尿失禁与混合性尿失禁。而据一项调查显示,压力性尿失禁的患病率占 35%,是临床上较为常见的患病类型。主要表现为腹压骤然增加时,尿液从尿道口不自主流出,而在平时无漏尿表现。

此病的发病原因较为复杂,但主要发病原因还是妊娠和分娩造成盆底支持结构的损伤。而根据不同的病因和不同的疾病分型可有不同的治疗方法。对于重度尿失禁患者主要采用手术方法治疗,而对于轻、中度尿失禁患者则主要采用非手术治疗。非手术方法众多,主要有盆底肌肉锻炼法,生物学反馈治疗,电刺激治疗,局部注射治疗,药物治疗等。而本次研究中主要对运用低频电刺激与盆腔生物反馈治疗的女性压力性尿失禁患者的临床效果进行分析、总结。研究结果显示低频电刺激与盆腔生物反馈治疗能较为有效的增强患者盆底肌力,改善漏尿的症状,提高患者的生活质量,总有效率达 89.7%,与治疗前差异具有统计学意义 ($P < 0.05$),而且无并发症的发生,复发率也较

低,仅有 2 例出现反复,经继续治疗好转。

生物学反馈治疗,是使医生或患者通过声音或视觉模拟信号所提示(或反映)的患者正常及异常盆底肌肉活动的状态,来了解盆底肌肉锻炼的情况,从而指导制定正确的、更有效的盆底肌肉锻炼方案^[5]。这种治疗方法既安全、有效,又简单、低廉、可重复治疗,无不良反应及并发症,既能保障患者治疗效果,又能提高患者的生活质量,值得临床推广应用。

参考文献

[1] 吴希庆,贾丕丽,萨音白刚. 生物反馈电刺激治疗女性压力性尿失

禁疗效分析 [J]. 疾病监测与控制,2010,4(12):667-668.

[2] 鞠华妹,施如霞,吴国霞. 生物反馈电刺激联合阴道锥治疗女性压力性尿失禁的疗效观察 [J]. 实用临床医药杂志,2011,14(5):46-48.

[3] 续奇志,邵晋凯,申丽萍. 生物反馈电刺激联合盆底肌训练治疗女性轻中度压力性尿失禁 [J]. 山西职工医学院学报,2009,23(3):3-5.

[4] 张有春,蒋本贵. 生物反馈电刺激联合盆底肌训练治疗女性压力性尿失禁的效果 [J]. 现代实用医学,2012,19(7):758-760.

[5] 刘洪梅,张洁. 电刺激联合生物反馈盆底肌锻炼治疗女性压力性尿失禁的疗效观察 [J]. 中国妇幼保健,2011,26(35):5638-5639.

(收稿日期:2013-09-23)

地氯雷他定联合糠酸莫米松治疗小儿丘疹性荨麻疹疗效观察

陈蕊,尹光文

(1. 郑州大学第一附属医院 皮肤性病科 河南 郑州 450052; 2. 商丘市第四人民医院 皮肤科 河南 商丘 476100)

摘要: 目的: 观察地氯雷他定干混悬剂联合糠酸莫米松乳膏治疗小儿丘疹性荨麻疹的临床疗效。方法: 将 100 例患儿随机分为两组,对照组 50 例外用糠酸莫米松乳膏,治疗组 50 例采用糠酸莫米松乳膏+口服地氯雷他定干混悬剂,治疗 5 d 后观察临床疗效。所得数据采用 SPSS 17.0 软件进行统计分析。结果: 治疗组的总有效率为 94.0%,对照组的总有效率为 80.0%,两组之间比较差异具有统计学意义($P < 0.05$)。结论: 地氯雷他定干混悬剂联合糠酸莫米松乳膏治疗丘疹性荨麻疹,起效快、安全性好,疗效确切,值得临床推广。

关键词: 地氯雷他定干混悬剂; 糠酸莫米松乳膏; 丘疹性荨麻疹

中图分类号: R 758.24 **doi:** 10.3969/j.issn.1004-437X.2013.06.045

丘疹性荨麻疹亦称虫咬皮炎,好发于春秋季节,是儿童常见的一种以鲜红色风团样丘疹为特征的皮肤病,多见于 2~7 岁幼儿。该病好发于躯干及四肢近段,损害数目不定,常分批出现,主要损害为红色风团样丘疹,呈纺锤形或圆形,中央常有丘疱疹,水疱或大疱,自觉瘙痒剧烈,夜晚更显著。临床上以外用药物治疗为主,但单纯外用皮质类固醇激素疗效欠佳,本文使用地氯雷他定干混悬剂联合糠酸莫米松乳膏治疗丘疹性荨麻疹 50 例,现将结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料 选择 2011 年 3 月至 2011 年 7 月在郑州大学第一附属医院皮肤科门诊和河南省商丘市第四人民医院皮肤科门诊就诊的丘疹性荨麻疹患儿 100

例,临床表现符合丘疹性荨麻疹诊断标准,近 2 周内未服用或外用糖皮质激素及其他抗组胺药物,排除细菌及真菌感染,无严重心、肝、肾等内脏及系统性疾病。将所有患儿随机分为两组:对照组 50 例,男 20 例,女 30 例,年龄 8 个月~10 岁,病程 3~5 个月,皮损个数 127 个;治疗组 50 例,男 25 例,女 25 例,年龄 6 个月~12 岁,病程 3~6 个月,皮损个数 138 个。两组患儿的性别构成、病程及皮损情况等基本资料进行比较,差异无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 治疗方法 对照组外用糠酸莫米松涂擦患处 2 次/d,治疗组加服地氯雷他定干混悬剂,2~5 岁儿童,1.25 mg/次,1 次/d;6~11 岁儿童,2.5 mg/次,1 次/d;用药期间两组患儿需同时避免搔抓热水洗烫等刺激因素。两组患儿均连续用药 5 d。

1.3 疗效判定标准 痊愈:皮损消退完全,瘙痒消失,可遗留色素沉着;显效:皮损消失 $\geq 80\%$,瘙痒明显减

通讯作者:尹光文,E-mail:yinguangwen1976@aliyun.com。